

هذا فحص تفصيلي للحالب — الأنبوب الذي يحمل البول من الكلية إلى المثانة — يُجرى أثناء نومك تحت التخدير. يجمع جراحك بين عدة اختبارات لتحديد موضع التضيق وطوله بدقة، حتى يتمكن من التخطيط للإصلاح المناسب.

عن هذا الفحص

يصعب قياس التضيق (stricture) في الحالب من الخارج، لذا يفحصه جراحك مباشرة أثناء نومك. قد يشمل الفحص أي مزيج مما يلي حسب الحاجة:

- **تنظير الحالب التشخيصي** — كاميرا رفيعة ومرنة تُمرر داخل الحالب للرؤية المباشرة.
- **تصوير الحوض الكلوي الرجعي** — حقن صبغة صعوداً من المثانة عبر الحالب مع أشعة سينية لرسم القناة.
- **تصوير الحوض الكلوي الأمامي** — إن كان لديك أنبوب صرف كلوي، تُسقط الصبغة نزولاً من الأعلى عبر التضيق.
- **تنظير المثانة / تصويرها** — فحص المثانة والنقاط صور بالأشعة.

الهدف هو رسم خريطة دقيقة لموضع التضيق وطوله ودرجة ضيقه. قد يُوضع دعامة (stent) أو أنبوب كلوي أو يُستبدل خلال الزيارة ذاتها.

هل هو آمن؟

نعم. هذا فحص شائع منخفض الخطورة. معظم الناس يلاحظون دماً خفيفاً في البول، أو حرقّة خفيفة، أو ألماً طفيفاً في الخصرة بعده. المضاعفات غير الشائعة تشمل عدوى البول أو تهيج الحالب المؤقت؛ وإصابة الحالب نادرة جداً. التخدير آمن بوجه عام.

تعلم المصطلحات

الحالب

الأنبوب الذي يحمل البول من الكلية إلى المثانة.

Stricture (تضيق)

منطقة متندبة ضيقة تُبطئ تدفق البول أو تسدّه.

تنظير الحالب

فحص داخل الحالب بكاميرا رفيعة ومرنة.

تصوير الحوض الكلوي الرجعي

أشعة سينية بعد حقن صبغة صعوداً من المثانة.

تصوير الحوض الكلوي الأمامي

أشعة سينية بعد إسقاط صبغة نزولاً من أنبوب الصرف الكلوي.

أنبوب الكلية (nephrostomy tube)

أنبوب يصرف الكلية عبر الظهر؛ يمكن حقن الصبغة من خلاله.

صبغة التباين

سائل يظهر أبيض في الأشعة السينية ليُظهر شكل القناة.

Stent (دعامة)

أنبوب داخلي لئلا يبقى الحالب مفتوحاً؛ قد يُوضع أو يُستبدل.

هل سيؤلم؟ أنت نائم تحت التخدير ولا تشعر بشيء أثناء الفحص. بعده قد تشعر بحرقة خفيفة عند التبول، أو ألم طفيف في الخصرة، أو بول مثلون بالدم لمدة يوم أو يومين. الإجراء قصير وعادةً تعود إلى منزلك في اليوم ذاته.

كيف تستعدّ (قبل الفحص)

- يُجرى هذا الفحص تحت التخدير — اتّبع جميع تعليمات الجراحة (الصيام، والأدوية الواجب إيقافها بما فيها مرقّقات الدم).

- تحليل البول يكشف العدوى — يجب علاج أي عدوى نشطة أولاً.

- اترك أي أنبوب كلوي أو دعامة موجودة في مكانها، ورتّب وسيلة عودة إلى المنزل.

أخبر فريقك الطبي مسبقاً إذا كنت:

- سبق أن تعرّضت لتفاعل مع صبغة الأشعة أو اليود
- تتناول مرقّقات الدم، أو لديك أعراض عدوى بولية

ما الذي يحدث أثناء الفحص

- 1 أنت نائم تحت التخدير وتُعطى لك المضادات الحيوية.

- 2 يُمرّر المنظار إلى المثانة، وتُحقن الصبغة صعوداً عبر الحالب مع أخذ الأشعة، و/أو تُمرّر الكاميرا داخله للفحص المباشر.

- 3 إن كان لديك أنبوب كلوي، قد تُسقط الصبغة نزولاً لإظهار التضيق من الاتجاهين.

- 4 تُسجّل النتائج على الخريطة، وتُوضع الدعامة أو الأنبوب الكلوي أو يُستبدل عند الحاجة.

بعد الفحص

- تتعافى من التخدير وعادةً تعود إلى المنزل في اليوم ذاته مع مرافق.
- قد تشعر بحرقة خفيفة أو ألم في الخصرة أو بول وردي اللون ليوم أو يومين. شرب الماء الإضافي يساعد.
- إن وُضعت دعامة، فإن بعض الإلحاح أو الانزعاج الخفيف عند التبول أمر طبيعي.
- تراجع جرّاحك نتائج الخريطة وناقش معك خطوات الإصلاح التالية.

اتصل بفريقك الطبي إذا كان لديك:

- حمّى أو قشعريرة
- ألم شديد أو متزايد في الخصرة أو البطن
- نزيف غزير أو جلطات دموية في البول
- صعوبة في التبول، أو غثيان أو قيء مستمر

ثلاثة أمور تذكّرها

1. يرسم هذا الفحص خريطة لتضيّق الحالب أثناء نومك، باستخدام كاميرا صغيرة وصبغة أشعة من الأسفل و/أو الأعلى، ليتمكن جرّاحك من التخطيط للإصلاح المناسب.
2. لأن التخدير مُستخدَم، اتّبع تعليمات الصيام والأدوية، وعالج أي عدوى أولاً، واطرك الأنبوب الكلوي أو الدعامة في مكانها، ورتّب وسيلة عودة.
3. معظم الناس يعودون إلى المنزل في اليوم ذاته. الحرقة الخفيفة وآلم الخصرة والبول الوردي لمدة يوم أو يومين أمر طبيعي — اشرب ماءً إضافياً، واتصل بفريقك عند الحمّى أو الألم الشديد أو النزيف الغزير.